

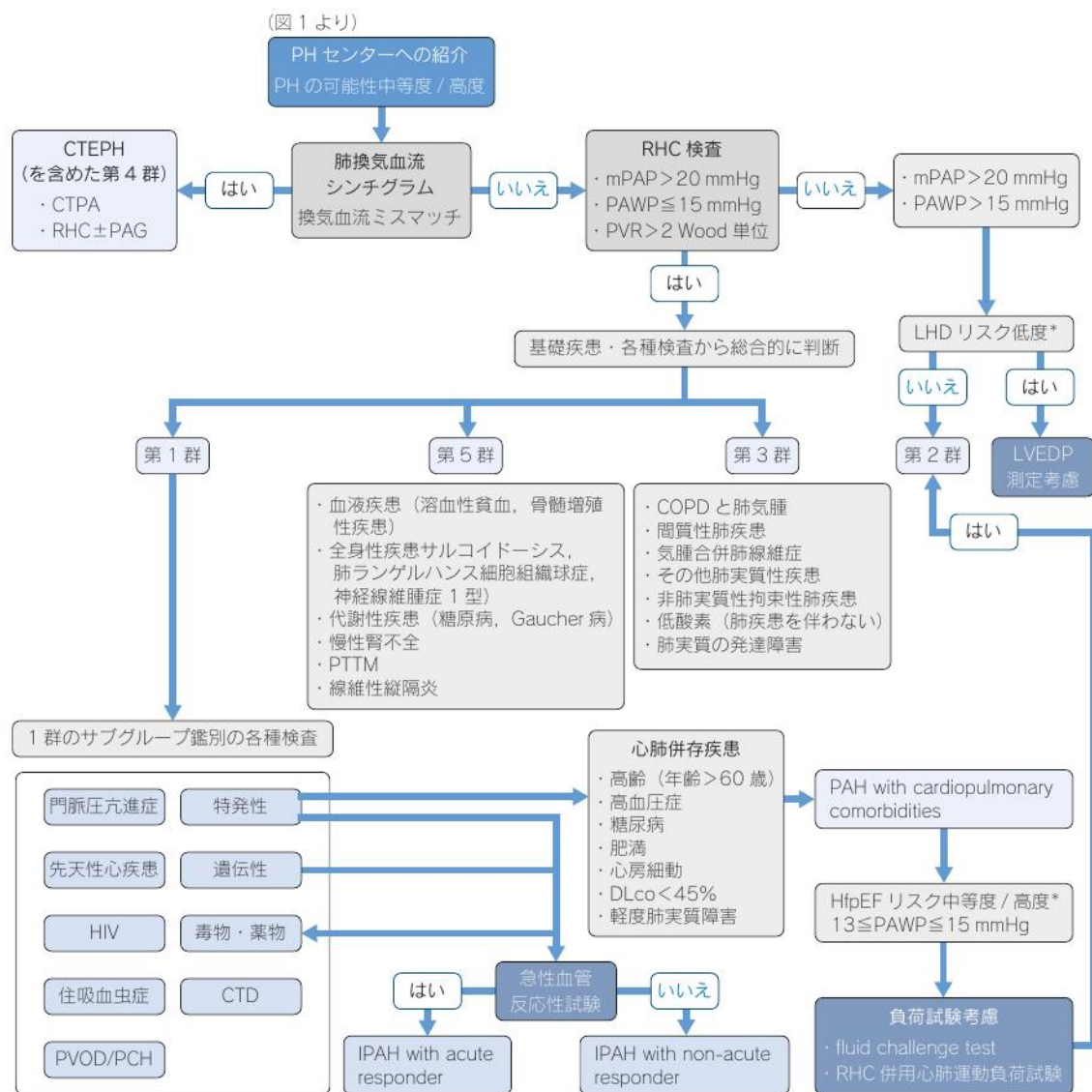


図 2 PH の鑑別アルゴリズム

\*数値や記載内容はあくまで参考であり、最終的には個々の症例ごとに判断する。

[日本循環器病学会/日本肺高血圧・肺循環学会：2025 年改訂版肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症治療に関するガイドライン [http://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/03/JCS2025\\_Tamura.pdf](http://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/03/JCS2025_Tamura.pdf) (2026 年 2 月閲覧)]

する。

## 診断・検査

労作時呼吸困難や失神などの症状から重篤な心肺疾患の存在が疑われる症例で、明らかな心疾患・呼吸器疾患、貧血や代謝疾患など労作時呼吸困難を主訴とする疾患の存在を指摘できない場合、肺高血圧症を疑う必要がある。一般的には『肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症治療に関するガイドライン』<sup>2)</sup>を参考に検査を進める (図 1, 図 2)。

## a 一般的な検査

心電図では右軸偏位、V<sub>1</sub> の R 波増高 (7 mm 以上)

や R/S 比 > 1, V<sub>5</sub>, V<sub>6</sub> での R/S 比 < 1 右室ストレイン、などや右房負荷に伴う肺性 P 波などがみられる。胸部 X 線写真では心陰影で左第 2 弓の突出、両側肺動脈近位部の拡張と末梢肺動脈の急峻な狭小化などの所見が認められるが、肺野の変化は乏しいことが特徴である。心エコー・ドプラ法は簡便で非侵襲的な肺高血圧の診断法として確立しており、本症が疑われる場合の必須な検査法である。心エコー法で右室の拡大や左室の扁平化、ドプラ法で肺動脈圧の上昇を認めれば右心カテーテル検査を行い、平均肺動脈圧 > 20 mmHg であれば肺高血圧症の診断が確定する。